Unimed Chapecó	**RELATÓRIO DE AUDITORIA FARMACÊUTICA NO CENTRO CIRÚRGICO**

1. **Introdução**

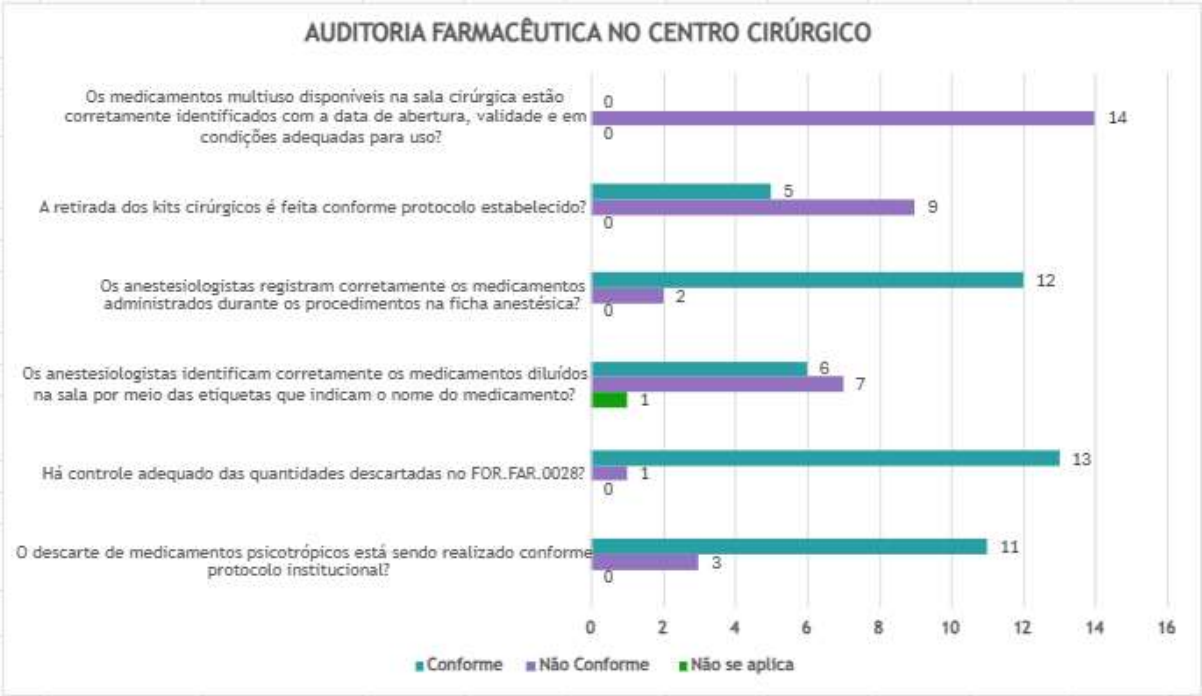
   O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados das auditorias farmacêuticas realizadas *in loco* no Centro Cirúrgico, com foco na conformidade dos processos relacionados ao uso, identificação e descarte de medicamentos, bem como na observância dos protocolos institucionais.

2. **Metodologia**

   As auditorias foram conduzidas pela equipe farmacêutica durante o mês de outubro, abrangendo diferentes salas cirúrgicas e turnos. Foram avaliados aspectos referentes à identificação de medicamentos multiuso, registro em ficha anestésica, retirada de kits psicobox®, controle de psicotrópicos e descarte de medicamentos. Os resultados foram classificados como: Conforme, Não Conforme e Não se aplica.

3. **Resultados**

   As avaliações evidenciaram não conformidades relevantes que demandam ações corretivas e reforço das orientações às equipes.



Os resultados indicam maior frequência de não conformidades nas etapas de registro na retirada do kit psicobox®, identificação de medicamentos diluídos e a

identificação de medicamentos multidose, o que reforça a necessidade de padronização e monitoramento contínuo.

4. Principais Não Conformidades

Xylestesin® spray sem identificação da data de abertura - responsabilidade da equipe de enfermagem no momento da reposição do produto na sala. Constatou-se a ausência da etiqueta de identificação, a qual deve ser fornecida junto ao produto pela CAF para que a equipe registre a data de abertura.

Ausência de horário e carimbo/CRM na retirada do kit psicobox - responsabilidade dos médicos anestesiologistas.

Seringas e soluções contendo medicamentos sem identificação - responsabilidade dos médicos anestesiologistas.

Preenchimento do formulário FOR.FAR.0028 antes do término do procedimento - responsabilidade dos médicos anestesiologistas. As equipes de enfermagem relatam não presenciar o descarte com frequência, além de situações em que os médicos solicitam a assinatura antes do encerramento do procedimento.

Descarte inadequado de psicotrópicos (sobras de Ketamin e Propofol no Descarpack) - responsabilidade compartilhada entre médicos anestesiologistas e equipe de enfermagem, quanto à execução e verificação do descarte.

Ausência de pó solidificador nas lixeiras químicas destinadas ao descarte de medicamentos, tornando o processo institucional não conforme - responsabilidade da equipe de higiene.

5. Sugestão de ações de melhorias

O presente relatório será compartilhado com a coordenação do Centro Cirúrgico, Higiene e Anestesiologia, que com base nos achados, irão avaliar a necessidade de planejar ações junto às equipes, com foco nas seguintes ações:

• Fortalecer as rotinas de identificação dos medicamentos abertos e diluídos.

• Garantir a dupla verificação dos formulários de descarte e do próprio processo de descarte.

• Reforçar à equipe de enfermagem que a assinatura no formulário de descarte deve ocorrer apenas mediante a presença e conferência do ato. Estimular a equipe da enfermagem a notificar as não conformidades no sistema Epimed.

• Manter auditorias mensais para acompanhamento da evolução das conformidades.

Essas medidas visam reduzir a reincidência das não conformidades e consolidar práticas assistenciais seguras e padronizadas.

6. Conclusão

As auditorias farmacêuticas realizadas evidenciam o comprometimento das equipes com a segurança e conformidade dos processos, porém destacam a necessidade de ações contínuas de aprimoramento. A manutenção do monitoramento in loco e a retroalimentação dos resultados serão fundamentais para fortalecer a cultura de segurança e o uso racional de medicamentos no Centro Cirúrgico.